Allegato 2:
Misure di controllo per la gestione del paziente con scabbia in ambito ospedaliero

MISURE DI CONTROLLO PER SCABBIA IN AMBITO OSPEDALIERO	
1 **PERSONALE SANITARIO** 	Utilizzare guanti e camice monouso (*a maniche lunghe*) non sterile, ogni volta che si viene a contatto con cute, lenzuola, e biancheria del paziente; eseguire igiene delle mani sia prima della vestizione che dopo la svestizione e/o rimozione guanti. Non è necessario l'uso della cuffia e della mascherina. Cambiare quotidianamente la divisa.
2 **PAZIENTE** 	Isolamento da contatto di 24 ore in stanza singola solo **nei casi di scabbia norvegese.** Per gli altri casi di scabbia adottare le precauzioni standard e specifiche. Limitare il più possibile le visite. I visitatori devono essere dotati di appositi guanti e camici monouso non sterili. **EDUCAZIONE SANITARIA:** Se degente autosufficiente e collaborante: istruire il paziente sulle norme igieniche da osservare per prevenire la diffusione degli acari ad altri degenti o all'ambiente. Per evitare le sovra infezioni da lesioni da grattamento si richiede il taglio delle le unghie. In caso di non autosufficienza, provvedere al taglio delle unghie.
3 **TRATTAMENTO INDUMENTI DEL PAZIENTE** 	All'arrivo del paziente e dopo l'esecuzione del trattamento topico cutaneo, inserire la biancheria personale in un sacco di plastica scuro e chiuderlo per il lavaggio a domicilio, (*vedi informativa allegata per le indicazioni a domicilio*). Educare i famigliari e/o caregivers a fornire biancheria personale possibilmente in cotone e/o fibra naturale per favorire una migliore traspirazione cutanea.
4 **TRATTAMENTO EFFETTI LETTERECCI** 	Eseguire il cambio effetti letterecci quotidianamente senza sollevare, scuotere e/o appoggiare la biancheria sulle suppellettili e/o pavimento per evitare possibili dispersione aerea e ricaduta sull'ambiente. Inserire gli effetti letterecci (lenzuola, federe, ecc..) in un apposito sacco idrosolubile che deve essere posto in un secondo sacco di colore rosso e chiuderli immediatamente; i cuscini ed i materassi devono essere raccolti in appositi sacchi dedicati forniti dalla ditta Lavanolo e/o della ditta che fornisce materassi antidecubito, apportando la dicitura **MATERIALE INFETTO**.
5 **OGGETTI O MATERIALI RIUTILIZZABILI** 	Quando è possibile, assegnare i presidi non critici (*es. sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro*) al singolo degente. Qualora ciò non sia possibile, è necessario disinfettare il presidio prima del prossimo utilizzo seguendo le informazioni fornite dal fabbricante del presidio. Per padelle e/o presidi per raccolta urine, se possibile usare il monouso altrimenti è sufficiente un ciclo termo-disinfettante in attrezzatura lava padelle.

MISURE DI CONTROLLO PER SCABBIA IN AMBITO OSPEDALIERO	
6 **SANIFICAZIONE AMBIENTALE** 	Considerata la scarsa resistenza degli acari nell'ambiente (*massimo 1 -2 gg.*), sono di norma sufficienti le routinarie operazioni di sanificazione e disinfezione ambientale. La sanificazione deve essere eseguita dopo la pulizia delle altre camere di degenza e se possibile utilizzando panni monouso. Fornire indicazioni agli operatori esterni della Ditta delle pulizie sulle corrette modalità di comportamento e vigilare sull'adozione delle stesse. **NOTA BENE:** Solo in caso di scabbia norvegese la sanificazione ambientale **dovrà essere eseguita 2 volte al giorno** con le modalità sopra descritte fino alla dimissione e/o trasferimento.
7 **ELIMINAZIONE RIFIUTI** 	Posizionare all'interno della camera di degenza un contenitore con coperchio per i **"RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO"** dove eliminare direttamente tutto il materiale non riutilizzabile venuto a contatto con il paziente e i dispositivi di protezione degli operatori.
8 **CAMPIONI BIOLOGICI** 	Porre attenzione nella raccolta di campioni soprattutto quando si tratta di prelievi ottenuti con la scarificazione della cute. Trasportare i campioni con i guanti e con gli adeguati contenitori. Nel caso di prelievo ematico **non utilizzare antisettici a base di alcool** perché sono irritanti per la cute di questi pazienti.
9 **COMPORTAMENTI** 	Limitare le uscite del degente dalla camera ai soli scopi essenziali; se lo spostamento è indispensabile, è necessario informare il personale della struttura presso la quale il degente viene trasferito e l'addetto al trasporto. **NOTA BENE:** si consiglia di evitare lo scambio di indumenti sanitari, (*es. felpe e/o maglioni*) tra il personale sanitario.